



図1 ヒトメタニューモウイルス肺炎の胸部 CT
気管支壁肥厚と気管支周囲のすりガラス陰影がみられる。

multiplex-PCR が開発され、多種の呼吸器ウイルスを一度にスクリーニングできることが可能となっており、日常臨床での応用が期待されている⁴⁾。

ウイルス性肺炎の CT パターンは、個々のウイルスの病原性に関連しており、ウイルス科によって類似な画像パターンを呈するとされる¹⁾。RS ウイルスやヒトメタニューモウイルスは気管支壁肥厚や小葉中心性の陰影を呈し、インフルエンザウイルスでは気管支血管束に沿った多発性の浸潤影や、小葉間隔壁肥厚を伴うすりガラス陰影などがみられる。SARS-CoV-2 では、両側多巣性、末梢優位、非区域性分布のすりガラス影および浸潤影がみられる。ヘルペスウイルス科では多発性の小結節陰影やすりガラス陰影を呈することが多いとされる¹⁾。浸潤影やすりガラス陰影は多くのウイルスでみられる。患者の免疫状態によっては典型的な画像を呈しない場合もあるため注意を要する。患者背景や全身症状と画像所見からウイルス感染を想起し、鑑別のため各種検査を行うことが重要である。図1にヒトメタニューモウイルス肺炎、図2に水痘・帯状疱疹ウイルス肺炎、図3にインフルエンザ肺炎の CT 像を示す。

治療と予後

現時点で、ウイルス性肺炎において治療法が確立しているのはインフルエンザと CMV 肺炎と SARS-CoV-2 のみである。抗インフルエンザ薬としては oseltamivir, zanamivir, laninamivir, peramivir, baloxavir が使用可能であり、患者背景や重症度に応じた薬剤の選択が推奨されており⁵⁾、肺炎症例では oseltamivir か peramivir が適応となる。肺炎を含むインフルエンザの合併症のリスクとしては①65 歳以上、②慢性呼吸器疾患、③心血管疾患、④慢性腎・肝・血液・代謝疾患、⑤神経筋疾患、⑥免疫抑制状態、⑦妊婦、⑧長期療養施設入所者、⑨著しい肥満、⑩ aspirin 長期投与を受けている者、⑪担癌患者などが挙げられている⁵⁾。SARS-CoV に対する治療は次項



図2 水痘・帯状疱疹ウイルス性による肺炎の胸部 CT
びまん性の小粒状、小結節陰影およびすりガラス陰影がみられる。

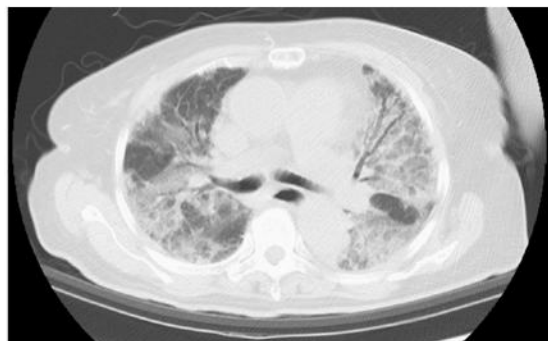


図3 インフルエンザウイルス肺炎の胸部 CT
小葉間隔壁肥厚を伴うすりガラス陰影および consolidation がみられる。

参照。CMV 感染の治療薬としては valganciclovir, ganciclovir, foscarnet があり ganciclovir が第一選択となる。ganciclovir 耐性や副作用がみられる場合に foscarnet が用いられる。

いずれのウイルスにおいても、混合性および二次性の細菌感染の合併があり、また、ウイルスと細菌の重複感染症例では、単一感染群と比較して、死亡率が高いとされており⁷⁾、必要に応じて抗菌薬やその他の補助療法の併用も行う。

文 献

- 1) Koo HJ, et al : Radiographics 38 : 719, 2018
- 2) Burk M, et al : Eur Respir Rev 25: 178, 2016
- 3) Ruuskanen O, et al : Lancet 377 : 1264, 2011
- 4) Chan M, et al : J Clin Virol 106 : 13, 2018
- 5) 厚生労働省：成人の新型インフルエンザ治療ガイドライン、第2版、2017
- 6) 診療の手引き編集委員会：新型コロナウイルス診療の手引き第10.1版
- 7) Voiriot G, et al : Crit Care 20 : 375, 2016